地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の皆さまへ

訪問の前に、見落としを減らす。「訪問前チェック」の試作のご案内

状況を声で話すだけで、「確認すること・気をつけること」が、LINEに返ってくる仕組みを試作しています。

どんな流れか

① 状況を話す
訪問の前や後に、LINEで、30秒ほど。「80代女性・独居、物忘れで薬の飲み忘れ…」（氏名は話しません）

② AIが項目を拾う
国が示す「適切なケアマネジメント手法（認知症）」の41項目から、いまの状況に合うものを選びます。

③ LINEに返る
確認すること、気をつけること、相談先の専門職の例を、出典つきの短いリストで返します。

根拠にしているもの

- **適切なケアマネジメント手法** 疾患別ケア：認知症 項目一覧（日本総合研究所・令和6年12月版）
- **高齢者虐待**：厚生労働省 老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（令和8年3月）

返答には、必ず「どの項目から」を表示します。

気になる様子があったとき

「あざ」「言葉が荒い」など、気になる言葉があれば、**虐待かどうかは判断せず**、市町村・包括への相談を促し、事実確認で見るポイント（安全・身体・精神・生活環境・養護者の状況）を示します。

安全のために決めていること

- AIは**確認の補助**です。ケアの判断・虐待かどうかの判断は、必ず人（ケアマネ・多職種・市町村・包括）が行います。
- **氏名は入れない**運用です（年代・性別・状況のみ）。訪問中の録音は想定せず、訪問の前後にケアマネ本人が話します。
- 先方の環境で動かす形も選べます（氏名を扱う場合など）。

いま作っている試作（架空の例で、お試しいただけます）

状況を入力すると、項目つきのチェックリストが出ます。実際の利用者さんの情報は、一切入っていません。
これは**画面で確かめる版**です。LINEで返す版は、いただいたご意見を聞いてから作ります。

https://aidealize.com/preview/tekicare-99964/

ご意見をいただきたいこと

- 使う場面は、訪問の**前**ですか、**帰りの車の中**ですか。
- 迷うことが多いのは、どの状況ですか（認知症以外の疾患も含めて）。
- 欲しいのは、**チェックリスト**ですか、**短い文章**ですか。
- 虐待・特殊事例で、気づきの補助として、あれば良いものは何ですか。

AIdealize株式会社　眞貴田 正博　makita@aidealize.com